



PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE FDT 2024

JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO OU ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES

De acordo com o Edital de Abertura 01/2024, que rege este Processo Seletivo, argumentações inconsistentes, extemporâneas, que estiverem fora das especificações estabelecidas para a interposição, que contiverem questionamentos de natureza administrativa (por exemplo, relacionados às normas previamente estipuladas em Edital) não obterão resposta da banca avaliadora e, por isso, não terão respostas publicadas na *Internet*. Não serão computadas as questões não assinaladas na grade de respostas, nem as que contiverem mais de uma *resposta*, emenda ou rasura, ainda que legível.

NÍVEL SUPERIOR

MATÉRIA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO(S): MEDICINA VETERINÁRIA

QUESTÃO: 26 - MANTIDA alternativa 'B'. O pneumotórax é uma complicação frequente nos animais com trauma e geralmente é a causa mais provável de dispneia. Na maioria das vezes, é causado pela ruptura alveolar secundária ao aumento da pressão intratorácica contra a glote fechada. No paciente com dispneia grave por pneumotórax, a toracocentese deve ser realizada emergencialmente para permitir a expansão pulmonar e consequente ventilação alveolar. Portanto, gabarito mantido.

Referência Bibliográfica utilizada:

RABELO, R. **Emergências de Pequenos Animais – Condutas Clínicas e Cirúrgicas no Paciente Grave**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'C'. Quanto à análise do termo "segurança alimentar" utilizado na assertiva I, destacamos que ele foi empregado de acordo com o sentido amplo em que é frequentemente associado às políticas de vigilância sanitária e às práticas que garantem alimentos seguros e adequados à saúde pública. O objetivo da Instrução Normativa nº 77/2018 inclui o monitoramento sanitário de rebanhos com vistas a proteger não apenas a saúde animal, mas também a saúde humana, pois o manejo sanitário animal impacta diretamente a cadeia produtiva de alimentos. Embora o termo "segurança alimentar" seja frequentemente utilizado em contextos que englobam acesso a alimentos, ele também pode ser interpretado como parte das diretrizes de saúde pública voltadas à segurança dos alimentos. Neste sentido, a assertiva I reflete a relação entre o estado sanitário do rebanho e os esforços para evitar riscos à saúde pública e assegurar alimentos saudáveis, conforme as exigências normativas. Assim, o uso do termo "segurança alimentar" na assertiva não invalida a afirmação, visto que o contexto aborda diretamente a proteção à saúde animal e humana, que é o cerne das políticas públicas estabelecidas pela norma. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'B'. A protusão da terceira pálpebra (ou membrana nictitante) é considerada um sinal característico desde literaturas antigas, sendo por vezes descrito como "patognomônico". A postura de cavalete está contemplada na alternativa correta. Além disso, as demais alternativas apresentadas contêm pelo menos uma possibilidade diagnóstica não recomendada ou

utilizada para o diagnóstico do tétano, o que impediria de ser considerada correta. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'C'. As falhas reprodutivas em fêmeas recorrentes referem-se ao HVE-1 (e eventualmente o HVE-4), de fato. No entanto, a questão se refere aos *Herpes virus* equinos (que são cinco, com quatro tendo as patologias bem descritas) tanto em equinos machos quanto fêmeas e suas diferentes apresentações. O que há em comum nos diferentes tipos de HVE, independente da apresentação é a sintomatologia respiratória. Isso se aplica também, mas não só, ao HVE-1. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 46 - ANULADA. No período inicial da patologia em questão, o intestino delgado, em especial duodeno e jejuno, realmente apresentam ausência de motilidade. No entanto, se o candidato considerou todos os segmentos intestinais, de fato o termo ausência não está correto. Portanto, anula-se a questão.

CARGO(S): SERVIÇO SOCIAL

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'B'. O acesso a benefícios é incorporado como elemento estratégico para o tratamento em transplante (SERRANO; PEREIRA; JESUS et al., 2022), especialmente pelo fato de o indivíduo em tratamento estar impedido de trabalhar por questão de saúde (COLOMBO; SERRANO; SILVA et al., 2022). Portanto, gabarito mantido.

Referência Bibliográfica utilizada:

PEREIRA, V. A.; SERRANO, L. C. de A.; SILVA, R. F. da. Determinação social do ser cuidador: de linhas gerais ao tratamento em transplantes. *Serviço Social e Saúde*, Campinas, SP, v. 21, n. 00, p. e022007, 2023. DOI: 10.20396/sss.v21i00.8670601. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss/article/view/8670601>.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'B'. O fenômeno da violência contra a mulher não se configura diretamente um problema da área da saúde: é considerado tanto um problema de saúde individual quanto coletivo, por prejudicar a saúde das mulheres (Silva et al., 2015). Portanto, gabarito mantido.

Referência Bibliográfica utilizada:

SOUZA, Lídia de Jesus. FARIAS, Rita de Cássia Pereira. Violência doméstica no contexto de isolamento social pela pandemia de covid-19. *Serv. Soc. Soc.* (144). May-Sep 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-6628.288>.

CARGO(S): PSICOLOGIA

QUESTÃO: 23 - ANULADA. Efetivamente a ASSERTIVA I, apesar de apresentar-se como "falsa" no gabarito, é VERDADEIRA. O gabarito apresenta a ASSERTIVA III como falsa. A mesma é efetivamente FALSA, pois aponta que "A interação entre a tríade profissional de saúde-criança-família deve buscar a elaboração de um projeto terapêutico único e replicável a todas as crianças que enfrentam as adversidades da quimioterapia", sendo que o Projeto Terapêutico Único, conforme referência, é justamente único, desenvolvido a partir da SINGULARIDADE de cada caso, e portanto NÃO É REPLICÁVEL, conforme apresenta a questão. Por não haver alternativa correta, anula-se a questão.

QUESTÃO: 24 - MANTIDA alternativa 'C'. A assertiva em questão diz: "Um dos objetivos da intervenção é afastar os pensamentos negativos no grupo, pois eles aumentam sintomas depressivos que podem incidir no processo de tratamento e cura da doença" e é falsa pois: o estudo aponta que "os grupos de apoio ajudam a afastar os pensamentos negativos e a reduzir sintomas de depressão", mas não que "objetivam afastar". Pelo contrário, o item "Identificação de benefícios e barreiras do convívio no grupo" exemplifica benefícios do trabalho de pensamentos análogos aos aspectos negativos como perda e morte, trabalhados em grupo, ou seja, de abordar os pensamentos negativos no contexto do grupo. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 25 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'B' PARA ALTERNATIVA 'C'. Após a leitura dos recursos expostos e revisão da prova, identificou-se que houve um equívoco na divulgação do gabarito preliminar. EFETIVAMENTE, as assertivas II e III SÃO AS INCORRETAS. A primeira assertiva

é verdadeira, pois o estudo aponta que questões associadas à autoimagem podem contribuir para sentimentos de isolamento social e outras repercussões que incidem diretamente na qualidade de vida; a segunda assertiva é falsa, pois o estudo aponta que as intervenções psicológicas devem acompanhar todo o processo e iniciar desde o diagnóstico, e não somente no pós-operatório, como indica a assertiva; a terceira assertiva é falsa, pois a revisão feita aponta que as temáticas das relações médico-paciente e do suporte familiar são vistas em escassas publicações, sendo necessário, ao contrário do que afirma a assertiva, investir em mais estudos sobre estes aspectos; por fim, a quarta assertiva é verdadeira, pois aponta que “há pacientes que passam pela cirurgia em decorrência de doenças vasculares, por exemplo, e eles podem se sentir aliviados pela dor que sentiam anteriormente no membro que será retirado”. Dito isso, a resposta correta é "Apenas II e III", ou seja, resposta C do gabarito.

QUESTÃO: 39 - MANTIDA alternativa 'D'. A contextualização expressada se dá por se tratarem Crianças com Condições Crônicas e Complexas (CCC) em hospitalizações prolongadas, conforme enunciado da questão e abordado no texto. No trecho referido, “Para Moreira, quando o adoecimento crônico faz parte da vida desde o nascimento ou de seu período inicial, não há um momento de preexistência ao adoecimento. (Comentário: ou seja, período inicial da vida, isto é, a infância). Segue o parágrafo: Nestes casos, ele é uma experiência constitutiva do sujeito e gera circuitos de sociabilidade, amizade, temas, objetos e repertórios de vida que dialogam com o viver adoecido cronicamente, compondo, assim, o processo de desenvolvimento. Ao apropriar-se de si e do mundo a sua volta, a criança também se apropria das atividades cotidianas neste espaço e dos gestos que as compõem. Estas atividades, aparentemente comuns, rotineiras, elementares, formam os fundamentos dos modos de viver humano. A vida segue assim, composta por esses gestos ínfimos e elementares que viabilizam o viver cotidiano” (p 2). A seguir, transcreve-se o parágrafo que segue a este citado, que também corrobora com o exposto: Com relação à questão das vivências “serem constituintes”, como expresso no parágrafo acima citado, a questão que se coloca é justamente serem “constitutivas” (Comentário: Conforme o dicionário Michaelis On-line: 1) Que constitui, estabelece ou compõe; constituinte, formador, estruturador; 2) Que é a base, o fundamento, a essência de; essencial, fundamental, indispensável 3) Que é traço ou elemento característico, distinto ou próprio de algo ou alguém). Neste sentido, ser constitutivo se refere à questão de que as características, vivências e relações estabelecidas pelas Crianças com Condições Crônicas no ambiente hospitalar farão parte do seu desenvolvimento, o que não representa fazer o juízo ou afirmação de que serão “prejudiciais” (como expresso no recurso), “positivas” ou “negativas”. O objetivo é poder investigar e reconhecer as características e instrumentalizar práticas em saúde, como expresso no parágrafo: “A existência deste grupo de crianças com CCC, que cresce ao longo dos anos, impõe o desafio, aos pesquisadores e aos profissionais da assistência, de produzir conhecimentos que instrumentalizem as práticas em saúde, e auxiliem na reflexão crítica e construção de um cuidado de qualidade. Esse estudo tem como objetivo refletir sobre o cotidiano de crianças com CCC que passam longos períodos hospitalizadas na fase inicial da vida” (p. 2-3). Portanto, gabarito mantido.

Referência:

SIMONATO, Mariana Pereira; MITRE, Rosa Maria de Araujo; GALHEIGO, Sandra Maria. O cotidiano hospitalar de crianças com hospitalizações prolongadas: entre tramas dos cuidados com o corpo e as mediações possíveis. Interface Comunicação, Saúde, Educação, v. 23, p. e180383, 2019.

CARGO(S): ODONTOLOGIA

QUESTÃO: 27 - MANTIDA alternativa 'C'. A classificação ASA (*American Society of Anesthesiology*) é uma ferramenta importante para a avaliação pré-operatória do paciente. A classificação ASA é utilizada para avaliar o estado físico do paciente e tem estreita relação com a morbidade e a mortalidade. Na classificação **ASA I**: Paciente saudável, sem doenças crônicas ou graves e que não adota comportamentos de risco. Na classificação **ASA II**: Paciente com patologias sistêmicas leves a moderadas. São exemplos de condições e doenças leves no adulto: tabagista, alcoolista social, ansiedade, asma, gestante, obesos (IMC entre 30 e 40), DM controlada, doença pulmonar leve, PA estágio II. Para a OMS, são sintomas da ansiedade generalizada (TAG) a tensão muscular, taquicardia ou palpitações, dor no peito, sudorese, cefaleia, vertigem, náuseas e diarreia, calafrios e tremores, taquicardia e dispneia. A TAG também pode causar sintomas neurológicos, como: Perda de memória, Insônia, Dificuldade de concentração, Irritabilidade, Inquietação. Para Andrade, no livro “Terapêutica Medicamentosa em Odontologia” (2014), o paciente ASA 2 é portador de doença sistêmica moderada ou paciente de menor tolerância que o ASA I, por apresentar maior grau de ansiedade. Ademais, a ansiedade é um grande desafio durante o tratamento odontológico. Para alguns pacientes, cirurgias em odontologia podem gerar alterações emocionais, tais como medo e crises, impactando assim no tratamento, no qual pode ocorrer susceptíveis urgências ou emergências odontológicas. Diversos

estudos demonstram a importância da implantação de métodos de controle do medo e da ansiedade no ambiente clínico, a fim de evitar incidentes e gravidade nos tratamentos dos diagnósticos odontológicos. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'D'. A questão apresenta justamente dois sinônimos para a mesma condição com objetivo de esclarecer o leitor, "pacientes com luxações habituais ou recidivantes da ATM", e um erro de digitação (redicivantes) não é suficiente para confundir o respondente, principalmente porque a questão trata do tratamento das luxações e não na definição da condição. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. As amarras dentárias são métodos que tem por objetivo conter dentes e/ou fragmentos fraturados e promover imobilização dos dentes e/ou cotos ósseos para promover a cicatrização. Essas amarras podem ser classificadas em amarras interdentárias ou horizontais ou amarras intermaxilares ou verticais. Essas últimas são também chamadas de odontossínteses de bloqueio maxilomandibular e unem a maxila e a mandíbula através dos dentes. Para Prado (2018, página 586), "Os anéis ou alças de IVY, são tipos de odontossíntese em anéis, com finalidade de estabelecer um bloqueio maxilomandibular". Portanto, apesar das amarras de IVY iniciarem numa arcada, elas só estarão completas quando fechadas com o anel da outra arcada dentária. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. As luxações laterais são um tipo de traumatismo dental que ocorre quando um dente se desloca para uma direção diferente da axial, rompendo o ligamento periodontal e podendo causar fratura ou contusão no osso alveolar. Para Recchioni (2022), referência bibliográfica deste processo seletivo, na página 363, "a luxação lateral consiste no deslocamento do dente em qualquer direção lateral, geralmente associado às fraturas a uma compressão da parede alveolar, ou do osso cortical. Nas luxações extrusivas há um deslocamento parcial do dente para fora do alvéolo, em uma direção axial ou incisal. O dente se mostra alongado incisalmente, com uma mobilidade e o teste de sensibilidade pulpar negativo [...] o tratamento consiste no reposicionamento do dente ao seu alvéolo com anestesia e contenção flexível por 2 semanas". Se houver fratura óssea associada, contenção por mais 4 semanas. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 35 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'D'. A alternativa II foi equivocadamente considerada correta, porém, diferente do que a alternativa sugere, a osteotomia Le Fort I da maxila e sua segmentação em três segmentos é frequentemente utilizada nas discrepâncias anteroposteriores e transversas da face, SEM risco de necrose da maxila por perda da vascularização; a literatura aponta que as complicações de necrose avascular da maxila segmentada em três fragmentos são raras, com poucos casos na literatura, mas podem acontecer; tornando a assertiva errada. Já a assertiva IV está correta e fundamentada na obra "Minimally Invasive Orthognathic Surgery" (Swennen, G.R.J., 2023), capítulo 1: "Background and Introduction to Minimally Invasive Orthognathic Surgery; Minimally Invasive (MI) Orthognathic Surgery; MI Orthognathic Surgical Techniques". A assertiva IV descreve que a navegação intraoperatória oferece benefícios significativos, como menor trauma cirúrgico e perda sanguínea. No entanto, também aponta limitações, como maior custo e tempo cirúrgico. Trechos específicos do livro confirmam a exatidão da proposição: "Intraoperative navigation, which allows real-time evaluation of the position of surgical instruments and accurate transfer of the 3D virtual surgical treatment plan, represents another interesting surgical tool. Even though it has undeniable advantages and proven benefits (e.g., in orbital and reconstructive OMFS), it is unlikely that it will play a role in routine MI orthognathic surgery due to prolonged surgical operating time, learning curve, and higher cost". Tradução: A navegação intraoperatória, que permite a avaliação em tempo real da posição dos instrumentos cirúrgicos e a transferência precisa do plano de tratamento cirúrgico virtual em 3D, representa outra ferramenta cirúrgica interessante. Embora possua vantagens inegáveis e benefícios comprovados (por exemplo, em cirurgias orbitais e reconstrutivas na Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial), é improvável que desempenhe um papel na rotina das cirurgias ortognáticas minimamente invasivas devido ao prolongamento do tempo cirúrgico, à curva de aprendizado e ao custo elevado. Portanto, altera-se o gabarito.

QUESTÃO: 43 – ANULADA. A exposição inadequada ao flúor é um fator de risco e, segundo a OMS, é uma das causas do aumento da prevalência de doenças bucais, porém não é um agente causador de cárie, embora, quando presente no biofilme, impeça a formação da cárie pelo processo desremineralização. Portanto, anula-se a questão.

QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'D'. A pergunta feita era "Qual é a abordagem recomendada para o manejo de urgências odontológicas na atenção básica?". Portanto, o atendimento de urgência na

atenção básica preconizado no documento referido é alívio da dor e controle da infecção e posteriormente o paciente é encaminhado para realização do tratamento da condição que o trouxe a urgência, mas tudo dentro da unidade de saúde. O paciente deve sempre ser acompanhado pela unidade após uma consulta de urgência para que o dentista possa verificar se o quadro ficou resolvido. O encaminhamento para outros níveis de atenção não deve ser a regra, mas a continuidade do cuidado é um dos pressupostos do Ministério da Saúde para o atendimento aos usuários. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'D'. A pergunta refere-se ao diagnóstico diferencial da hipomineralização molar-incisivo com outros defeitos de estrutura do esmalte dentário, portanto a característica de hipersensibilidade é o que define o diagnóstico, e em relação a outras características e a multifatoriedade, a questão não refere que esse é o único sinal ou sintoma nem faz menção aos fatores causais. Do que está exposto, era necessário escolher uma característica que auxiliasse no diagnóstico diferencial. Segundo os autores, a ausência de envolvimento de cúspides, a ausência de lesões cariosas, aliadas à sensibilidade dental, determinam o diagnóstico de HMI moderada; e um elemento de destaque no caso apresentado foi a dificuldade de colaboração do paciente, devido à grande sensibilidade dental. As manchas que variam do branco ao castanho podem estar presentes na fluorose, na hipomineralização, na hipoplasia ou no processo inicial da cárie. A mancha branca ativa e a fluorose não apresentam hipersensibilidade, e geralmente a demais alterações de esmalte também não. Portanto, a única alternativa trazida como característica para o diagnóstico desta alteração é a hipersensibilidade. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 54 - ANULADA. Na alternativa A, deveria ter constado "indicado" e não "contraindicado", o que tornou a alternativa correta. Portanto, esta questão teria duas alternativas corretas. Sendo assim, anula-se a questão.

QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'A'. A leucoplasia pilosa está presente em muitas pessoas vivendo com HIV/AIDS, mas é a candidíase pseudomembranosa a doença que mais se manifesta na orofaringe na síndrome retroviral aguda, ou seja, na primo-infecção. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'B'. Apesar de existirem diferentes protocolos de tratamentos para as osteonecroses por medicamentos, a alternativa B está correta, pois está descrita no capítulo 30, página 215. As demais alternativas não estão corretas porque nem sempre pode-se remover o fator causal e mesmo que o façam há medicamentos que ficam aderidos ao osso por meses ou anos; porque não se usa antibiótico profilático pois não há fator preditivo para a ONM, somente após a detecção da osteonecrose; não há evidência que haja a retorno da irrigação da área óssea necrosada, mesmo com terapia hiperbárica, ela é somente um adjuvante no tratamento; e o cuidado com o paciente em uso de medicamentos que alteram o metabolismo ósseo deve ser uma constante no que se refere aos cuidados bucais. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'B'. A ação é diretamente relacionada com o efeito citotóxico dos agentes quimioterápicos ou indiretamente pela neutropenia, ou seja, há uma ação direta por formação de espécies reativas de oxigênio que posteriormente causam a apoptose e amplificam o processo inflamatório das reações mediadas pelas citocinas. Ação direta dos quimioterápicos sobre o epitélio oral não está correto porque o quimioterápico não vai promover uma destruição do epitélio imediatamente após sua ingestão ou infusão, mas sim, vai causar a morte celular, em especial dos tecidos com maior turn over, e dias depois pode desenvolver mucosite, portanto a ação não é direta no tecido epitelial e sim resultado de um processo. A toxicidade dos medicamentos vai estimular uma reação inflamatória mediada por citocinas como o Fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), por exemplo, entre outras responsáveis pela ação de defesa contra o corpo estranho que é o quimioterápico. Os autores Santos e Araújo de Albuquerque não estão referidos na bibliografia preconizada. A questão foi elaborada a partir da seguinte bibliografia:

HUPP, J.R.; ELLIS III, E.; TUCKER, M.R. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

WANNMACHER, L.; RÖSING, C.K. Terapia Medicamentosa em Odontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

CARGO(S): NUTRIÇÃO

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'B'. Conforme bibliografia sugerida para este concurso e utilizada (OLIVEIRA, FERNANDA LC. Manual de terapia nutricional pediátrica. Barueri: Manole, 2014. Pg 149-150), algumas das orientações para diarreia aguda infantil são:

- I – A alimentação usual, desde que nutricionalmente adequada, deve ser continuada;
 - II – Caso a criança receba leite de vaca, este não deve ser diluído para não se reduzir a oferta calórica;
 - III – O consumo de frutas, vegetais, cereais, leguminosas, carnes e ovos não deve ser restringido;
 - IV – Recomenda-se o aumento de uma ou mais refeições ao dia, preparadas com alimentos habituais, para compensar as perdas causadas pela diarreia e evitar piora do estado nutricional.
- Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão em discussão encontra-se correta e com as informações adequadas para classificar um indivíduo com pré-hipertensão a partir dos valores da pressão sistólica e diastólica. A falha na diagramação não inviabiliza o entendimento da questão pois trata-se apenas da falta de uma letra, no caso uma letra "m", para identificar milímetros de mercúrio (mmHg). Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 33 - MANTIDA alternativa 'C'. A primeira assertiva está incorreta pelo fato que ela descreve como deve ser constituída a dieta DASH e constam duas informações erradas: “laticínios integrais” e “consumo moderado.....carne” quando o correto é: “laticínios com baixo teor de gordura” e “consumo moderado.....carne vermelhas”. A assertiva escrita de forma correta é:

- I - A dieta DASH (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*) foi capaz de reduzir a PA, sendo o efeito atribuído ao maior consumo de frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura e cereais integrais, além de consumo moderado de oleaginosas e redução no consumo de gorduras, doces e bebidas com açúcar e carne vermelhas.

Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 34 - MANTIDA alternativa 'A'. Conforme bibliografia sugerida para este concurso e utilizada para a elaboração da questão (Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes - Manejo da terapia antidiabética no DM2), o controle glicêmico é essencial para a prevenção de complicações micro e macrovasculares relacionadas ao diabetes. Grandes ensaios clínicos randomizados (UKPDS, ADVANCE) mostraram a eficácia da redução sustentada da hemoglobina glicada (HbA1c) para abaixo de 7% em desfechos microvasculares, como retinopatia, doença renal e neuropatia.^{1,2} A redução de complicações macrovasculares, por sua vez, ocorre a longo prazo, e é mais evidente quando o controle glicêmico é iniciado mais precocemente, ainda no primeiro ano após o diagnóstico. Desta forma a resposta está de acordo com a orientação da bibliografia utilizada. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'D'. Conforme bibliografia sugerida para este concurso e utilizada para a elaboração da questão (OLIVEIRA, A. M., SILVA, F. M, SOUZA A. L. Dietoterapia nas doenças do adulto. 2ª ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2021 – Instabilidade hemodinâmica no Paciente Crítico - Pg 342). A 3ª parte afirma: a indicação do uso de nutrição trófica, com a nutrição enteral sendo administrada a um volume de 10ml/hora, com fórmula de baixa osmolaridade e isenta de fibras. Esta mesma indicação é feita por outra bibliografia indicada para este concurso (BRASPEN/2023) onde consta o volume de 10-20ml/hora e sabe-se que o início sempre deve ser cauteloso, iniciando com volume menor e evoluir de acordo com as reações fisiológicas do paciente. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'D'. A solicitação está indeferida, considerando que a assertiva III da questão está incorreta, pois afirma que a qualidade das refeições se sobrepõe à importância da regularidade de horários semelhantes para a realização das refeições, quando, na verdade, ambas são importantes. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'A'. A referência mencionada encontra-se no edital do referido concurso:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. **Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis no Brasil, 2021-2030**. Brasília: Ministério da Saúde, 2021 Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-2022_2030.pdf

A primeira assertiva está incorreta, considerando que o controle e tratamento das pessoas não são as portadoras de DCNT e sim de pessoas acometidas por agravos nutricionais. A última assertiva está incorreta, considerando que a avaliação do estado nutricional a partir da coleta de dados antropométricos e demarcadores de consumo alimentar, e não de dados bioquímicos e do consumo alimentar. As demais assertivas estão corretas de acordo com a página 5 e 6 da referência supracitada. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 45 - MANTIDA alternativa 'D'. A tabela TACO não faz parte das referências do edital do concurso. A resposta correta da questão é a letra D, e poderá ser encontrada na p. 30 da referência: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2014. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'D'. Esta questão tem como base as referências bibliográficas do edital do concurso. A resposta correta da questão é a letra D, considerando que a assertiva II registra uma afirmação falsa de que o estigma e a discriminação não resultam em maior morbimortalidade, quando na verdade, estudos mostram que é ao contrário: a discriminação resulta em maior morbimortalidade, assim como os efeitos psicológicos ao indivíduo alvo desses fatores. (TOMIYAMA et al., 2018; RUBINO et al., 2020). Esta resposta correta pode ser encontrada na p. 5 da referência: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_atencao_pessoas_sobrepeso_obesidade.pdf Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'D'. Esta questão tem como base as referências bibliográficas do edital do concurso. A resposta correta da questão é a letra D, considerando que, segundo o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos, todas as assertivas estão corretas, exceto a I, que trata dos casos de Mastite (inflamação da mama), onde a recomendação é de que a mãe deve procurar imediatamente um serviço de saúde, mas não precisa interromper a amamentação durante o tratamento, conforme a p. 10 do referido Guia: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos versão resumida. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_alimentar_2anos.pdf Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 55 - MANTIDA alternativa 'A'. A resposta correta é a letra A, considerando que a assertiva II está incorreta, pois a exposição a pequenas doses de leite vaca, nos primeiros dias de vida, aumenta o risco de alergia ao leite de vaca e não diminui. A assertiva III está errada, pois a principal proteína do leite humano é a lactoalbumina e não a caseína. Referência: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar. Capítulos 1 ao 14. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 59 - MANTIDA alternativa 'C'. A questão não aborda a responsabilidade exclusiva de algum profissional, mas exemplifica a atuação do nutricionista como membro da equipe apenas como exemplo já que a prova é de conhecimento específico da nutrição. Portanto, gabarito mantido.

CARGO(S): FISIOTERAPIA

QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'A'. O autor Sarmento (2018) apresenta as indicações e contraindicações para a realização de reabilitação cardiovascular, ou seja, realização de exercício físico. Angina instável, tromboflebite, bloqueio AV do 3º ramo (sem marca-passo) e arritmia não controlada são descritas pelo autor como contraindicação absoluta para realização do exercício físico. O infarto do miocárdio não é considerado uma contraindicação absoluta para realização de exercício, e sim uma indicação. A intensidade de exercício será estratificado durante a avaliação completa do paciente. Portanto, gabarito mantido.

CARGO(S): FARMÁCIA

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'. Para esclarecer a questão, segue abaixo a análise de cada assertiva:

O farmacêutico deve atuar com autonomia técnica, fornecendo informações criticamente avaliadas, objetivas e imparciais.

O Serviço de Informação sobre Medicamentos (SIM) pode ter abrangência nacional, mas não é necessariamente um local estruturado; ele pode ser uma rede de informações.

Como mencionado anteriormente, a Informação Ativa é aquela que é disponibilizada sem demanda.

O NAT é realmente constituído por profissionais de saúde que elaboram pareceres sobre medicina baseada em evidências.

A habilidade para processamento eletrônico de dados é uma atribuição do farmacêutico.

Agora, analisando corretamente, tem-se as seguintes afirmações corretas:

1 (Correta)

2 (Incorreta)

3 (Incorreta)

4 (Correta)

5 (Correta)

Portanto, as afirmações corretas são 1, 4 e 5, totalizando:

$1 + 4 + 5 = 10$.

A somatória correta é 10.

A alternativa correta é B) 10.

QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'B'. A questão e o gabarito estão corretos. A alternativa incorreta é a afirmação 5. As demais estão corretas. Portanto, o somatório dos itens corretos (1, 2, 3 e 4) resulta em 10.

CARGO(S): ENFERMAGEM

QUESTÃO: 21 - MANTIDA alternativa 'A'. A questão foi elaborada com base na bibliografia publicada no edital: BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria SECTICS nº14, de 08 de abril de 2024. Atualiza o **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pós Exposição (PEP) de risco de infecção pelo HIV, IST e Hepatites Virais**. Brasília DF, 2024.19 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria SCTIE/MS nº 90, de 25 de agosto de 2022. Atualiza o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de Risco à Infecção pelo HIV. Brasília, DF, 2022.

As bibliografias utilizadas trazem como população-chave "gays e outros homens que fazem sexo com homens, travestis e pessoas trans, trabalhadoras(es) do sexo, pessoas que usam álcool e outras drogas e pessoas privadas de liberdade. São consideradas populações prioritárias: indígenas, jovens, população negra e pessoas em situação de rua. Na PrEP, amplia-se ainda recomendação a todos os adultos e adolescentes sexualmente ativos sob risco aumentado de infecção pelo HIV, além da população-chave descrita". Assim, a alternativa está correta. Demais estão incorretas porque:

B) Pessoas que buscam atendimento para iniciar PEP após relação sexual consentida devem ser avaliadas para início futuro da PrEP.

C) Refere-se ações de prevenção às IST, ao HIV, às hepatites virais e seus fatores associados.

D) Adolescentes acima de 15 anos estão incluídos.

Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 22 - MANTIDA alternativa 'C'. Bibliografia utilizada e publicada no edital:

SOUSA, P.; MENDES, W., COMPS. **Segurança do paciente: conhecendo os riscos nas organizações de saúde**. 2nd ed. rev. Rio de Janeiro, RJ: CDEAD, ENSP, Editora FIOCRUZ, 2019.

Conforme a referida bibliografia, "a reação adversa ao medicamento é um dano inesperado que resulta de uma ação ou tratamento justificado em que o processo correto, para o contexto em que o evento ocorreu, foi implementado. Por exemplo, a diminuição anormal e inesperada do número de glóbulos brancos no sangue pela utilização de um medicamento em que se desconhecia esse efeito é uma reação adversa. Um efeito secundário é um efeito conhecido, para além do principalmente desejado, relacionado com as propriedades farmacológicas de um medicamento, tais como náusea após a administração de morfina para alívio das dores. O dano é o elemento comum na definição de evento adverso, presente nos estudos acadêmicos pioneiros e na ICPS. Não há evento adverso sem dano. Uma queda de

leito/cama sem nenhum dano ao paciente, por exemplo, é um incidente". Assim, conforme a bibliografia utilizada, gabarito mantido.

QUESTÃO: 23 - MANTIDA alternativa 'D'. Bibliografia utilizada e publicada em edital:

SOUSA, P.; MENDES, W., COMPS. **Segurança do paciente: conhecendo os riscos nas organizações de saúde**. 2nd ed. rev. Rio de Janeiro, RJ: CDEAD, ENSP, Editora FIOCRUZ, 2019.

A assertiva II está incorreta porque não houve erro de administração, visto que a técnica de enfermagem percebeu que era uma ampola de cloreto de potássio e desprezou a preparação. Logo não houve erro de administração. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 28 - MANTIDA alternativa 'D'. Bibliografia utilizada e publicada no edital:

BRASIL, Ministério da Saúde. **Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal**. Brasília - DF, 2022.

A alternativa C está incorreta porque recomenda-se que o puxo seja adiado por pelo menos uma hora, exceto se a mulher quiser realizar o puxo antes disso ou o polo cefálico estiver visível. Deve-se apoiar a realização de puxos espontâneos no segundo período do parto em parturientes sem analgesia, evitando os puxos dirigidos. A alternativa C traz que as mulheres com analgesia regional podem realizar puxos, quando a bibliografia traz que devem ser adiados. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 29 - MANTIDA alternativa 'A'. Bibliografia utilizada e publicada no edital:

BRASIL, Ministério da Saúde. **Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal**. Brasília - DF, 2022.

A primeira assertiva é verdadeira, com base na bibliografia utilizada, página 48. A segunda assertiva é falsa, porque, conforme bibliografia, a fase latente do primeiro período do parto é caracterizada por contrações uterinas dolorosas e alterações variáveis do colo do útero, incluindo algum grau de apagamento e progressão mais LENTA, e não rápida, e dilatação acima de 5 cm e não 6 cm, para nulíparas e multíparas. A terceira assertiva é verdadeira. A quarta assertiva é falsa, porque, conforme bibliografia, após 30 minutos ele já é considerado prolongado. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 30 - MANTIDA alternativa 'C'. Na assertiva I, a tonalidade do gráfico não traz impacto em relação a 2005 e 2006, visto que o objetivo da questão era informar que houve uma inversão da taxa de mortalidade de mulheres de raça/cor branca que reduziu e aumentou a de mulheres de raça/cor preta. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 31 - MANTIDA alternativa 'B'. Bibliografia utilizada e publicada:

Ministério da Saúde. **Protocolo de Atenção Básica: Saúde das Mulheres**. Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Brasília – DF – 2016.

Entre as situações colocadas na questão, a única em que não há contraindicação é câncer de mama atual. Sobre a alternativa C, a bibliografia traz que "se já se passaram mais de 48 horas após o parto, retarde a inserção do DIU por quatro semanas ou mais". Casos específicos podem ser avaliados, mas a recomendação é não realizar o procedimento neste período. A alternativa D traz DIP atual, que não é recomendado.

QUESTÃO: 32 - MANTIDA alternativa 'C'. Bibliografia utilizada e publicada no edital:

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar**. 2. ed. – Brasília, DF, 2015.

A referência postula sobre a evolução da alimentação da criança de acordo com a faixa etária. As alternativas trazem esta evolução, cabendo ao candidato identificar qual orientação alimentar é mais adequada para a faixa etária. A alternativa C traz a evolução do almoço e jantar, pedaços pequenos e bem cozidos e frutas em pedaços bem pequenos, condizente com a faixa etária do caso. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 35 - MANTIDA alternativa 'A'. Bibliografia utilizada e publicada em edital:

FEITOSA, A. D. M.; et al. **Diretrizes brasileiras de medidas da pressão arterial dentro e fora do consultório**. Arq Bras Cardiol. 2024.

A medida no consultório a partir de 18 anos de idade para a pressão 130-139 e/ou 85-89 é considerada pré-hipertensão. Considerando que a forma de registro dos valores da pressão arterial em qualquer instrumento é sistólica/diastólica, não havendo outro formato habitual, o enunciado está claro e mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 37 - MANTIDA alternativa 'A'. Bibliografia utilizada e publicada no edital:

BRASIL, Ministério da Saúde – INCA. **Detecção precoce do Câncer**. Rio de Janeiro. INCA, 2021. Categorias BI-RADS 3:

Provavelmente benigno – risco < 2%. Conduta - controle radiológico por três anos (semestral no primeiro ano e anual nos segundo e terceiro anos). Confirmando estabilidade da lesão, volta à rotina. Eventualmente, biópsia. Assim, considerando o enunciado da questão, a alternativa A é a que mais se enquadra nas características da categoria BI_RADS 3. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 38 - MANTIDA alternativa 'B'. Bibliografia utilizada e publicada no edital:

BRASIL. Ministério da Saúde. **Suporte Avançado de Vida**. Brasília. 2016. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolo de Intervenção para o SAMU – 192. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Segundo esta bibliografia, o DPOC tem as seguintes características: piora da dispnéia, aumento da produção de escarro e/ou alteração de sua característica (purulento). Outros sinais e sintomas: cianose, sinal de Kussmaul (ingurgitamento das veias do pescoço com inspiração), expiração forçada, redução do MV, roncos difusos, crepitações. A expectoração clara ou rósea é uma característica importante no edema agudo. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 41 - MANTIDA alternativa 'C'. De acordo com o Decreto nº 94.406/1987, que regulamenta a Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, assistir o enfermeiro na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave é uma atribuição do técnico de enfermagem. O verbo "assistir" é exatamente o que consta na Legislação.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. **Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987**. Regulamenta a Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências. Disponível em:

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-94406-8-junho-1987-444430-publicacaooriginal-1-pe.html>

Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 42 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com a Resolução nº 736/2024, que dispõe sobre a implementação do processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem, somente as etapas de Diagnóstico de Enfermagem e Prescrição de Enfermagem são privativas ao enfermeiro.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. **Resolução nº 736, de 17 de janeiro de 2024**. Dispõe sobre a implementação do processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/>

QUESTÃO: 44 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com a Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação (2024), a vacina da BCG em crianças nascidas com peso inferior a 2 Kg deve ser adiada até que atinjam este peso. Portanto, gabarito mantido.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Instrução Normativa do Calendário Nacional de Vacinação, 2024**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/publicacoes/instrucao-normativa-calendario-nacional-de-vacinacao-2024.pdf>

QUESTÃO: 47 - MANTIDA alternativa 'A'. De acordo com a classificação fisiopatológica do pé diabético que consta no Manual do Pé Diabético (2016), os sinais e sintomas descritos no enunciado da questão referem-se à classificação de um pé isquêmico, uma vez que ele se caracteriza tipicamente por história de claudicação intermitente e/ou dor à elevação do membro. Ao exame físico, pode-se observar rubor postural do pé e palidez à elevação do membro inferior. À palpação, o pé apresenta-se frio, podendo haver ausência dos pulsos tibial posterior e pedioso dorsal (pg12). O pé neuropático teria coloração normal, com aspecto da pele seca e fissurada, com temperatura do pé quente ou morna e com deformidades, com pulsos amplos e simétricos e presença de edema. Portanto, gabarito mantido.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Manual do Pé diabético – estratégia de cuidado para pessoa com doença crônica**. Brasília, DF, 2016. Disponível em: 189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/manual_do_pe_diabetico.pdf

QUESTÃO: 49 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellito Tipo 1 (referência citada no edital), a insulina NPH (*Neutral Protamine Hagedorn*) é uma suspensão cristalina de insulina formada pela adição de uma molécula de protamina, que prolonga seu efeito e promove ação intermediária; assim, essas modificações deram origem a insulina com perfil cinético próprio. A insulina NPH não deve ser administrada em monoterapia; o seu uso dá-se em combinação com a insulina regular ou com a insulina análoga monomérica de ação rápida. Portanto, gabarito mantido.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria Conjunta nº 17, de 12 de novembro de 2019**. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellito Tipo 1. Brasília. DF, 2019. Disponível

em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/arquivos/2023/portaria-conjunta-no-17-diabete-melito-tipo-1.pdf>

QUESTÃO: 50 - MANTIDA alternativa 'C'. O conceito refere-se ao Censo Vacinal: é um levantamento da situação vacinal de determinada localidade, e não tem uma definição de amostra da população avaliada. Trata-se de uma estratégia de supervisão das ações de vacinação, cujo objetivo principal é conhecer a realidade da situação vacinal de determinada localidade e resgatar os não vacinados. Portanto, gabarito mantido.

Conceito descrito na referência citada no edital:

Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. Volume 1. 6ª ed. rev. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-1-6a-edicao>

QUESTÃO: 54 - MANTIDA alternativa 'D'. O próprio enunciado da questão direciona aos aspectos que constam na Resolução nº 690/2022: "competem ao Enfermeiro realizar a inserção, revisão e retirada de Dispositivo Intrauterino-DIU". Portanto, gabarito mantido.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. **Resolução nº 690/2022, de 04 de fevereiro de 2022**. Normatiza a atuação do Enfermeiro no Planejamento Familiar e reprodutivo. Brasília, DF, 2022. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-690-2022/>

QUESTÃO: 56 - MANTIDA alternativa 'B'. De acordo com o protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Tabagismo, "independentemente da carga tabágica (número de cigarros/dia ou anos de tabagismo) e do grau de dependência à nicotina, a farmacoterapia não deve ser utilizada em pacientes que apresentem contraindicações clínicas ou por aqueles que optarem pelo não uso de medicamentos, mesmo após receberem esclarecimento adequado por parte do profissional da saúde que os acompanha". Portanto, gabarito mantido.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria conjunta nº 10, de 16 abril de 2020**. Aprova os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Tabagismo. Brasília, DF, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/arquivos/2020/pcdt_tabagismo.pdf

QUESTÃO: 57 - MANTIDA alternativa 'C'. As gestantes devem ser seguidas mensalmente com teste não treponêmico após o tratamento e NÃO trimestralmente, como está escrito na alternativa C, por isso essa é a alternativa INCORRETA que o enunciado solicita assinalar. Portanto, gabarito mantido.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. Volume 2. 6ª ed.rev. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>

QUESTÃO: 60 - MANTIDA alternativa 'C'. Durante o sexo vaginal, as taxas de transmissão de homens para mulheres são maiores do que de mulheres para homens. A ejaculação do homem infectado contém milhões de cepas da gonorreia, que serão injetadas efetivamente no local anatômico receptor (mucosa vaginal, anal ou oral). Desta forma, a alternativa INCORRETA é a C. Portanto, gabarito mantido.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia de Vigilância em Saúde**. Volume 2. 6ª ed.rev. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigilancia/guia-de-vigilancia-em-saude-volume-2-6a-edicao>

CARGO(S): BIOMEDICINA

QUESTÃO: 53 - MANTIDA alternativa 'D'. A resposta para a questão foi retirada do Capítulo 9 da referência:

MUNDT, Lillian A., SHANAHAN, Kristy. Exame de Urina e de Fluidos Corporais de Graff. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

Esta literatura foi disponibilizada previamente para preparação da prova. Trecho do livro:

"bacteriana, fúngica e tuberculosa (com frequência originam níveis de lactato acima de 35 mg/dL)". Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 54 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'B'. Houve falha na divulgação do gabarito, que realmente encontra-se na letra B. Portanto, altera-se o gabarito.

MATÉRIA: HUMANIZAÇÃO, SAÚDE COLETIVA; LEGISLAÇÃO, POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DO SUS

CARGO(S): TERAPIA OCUPACIONAL, MEDICINA VETERINÁRIA, SERVIÇO SOCIAL, PSICOLOGIA, ODONTOLOGIA, NUTRIÇÃO, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, FARMÁCIA, ENFERMAGEM, EDUCAÇÃO FÍSICA, BIOMEDICINA, GESTÃO EM SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE

QUESTÃO: 02 - MANTIDA alternativa 'A'. A fim de elucidar os questionamentos e as dúvidas relacionadas à questão nº 2, esclarece-se que todas as assertivas são consideradas CORRETAS e podem ser localizadas na literatura indicada no edital:

BRASIL. Ministério da Saúde. A Experiência da diretriz de ambiência na Política Nacional de Humanização – PNH. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: <http://redehumanizasus.net/lancamento-da-cartilha-humanizasus>.

Assertiva I – disponível na página 15 do documento supramencionado;

Assertiva II – disponível na página 10 do documento supramencionado;

Assertiva III – disponível na página 19 do documento supramencionado;

Assertiva IV – disponível na página 17 do documento supramencionado.

Dessa forma, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 06 - MANTIDA alternativa 'B'. A fim de elucidar os questionamentos e as dúvidas relacionadas à questão nº 6, esclarece-se que as assertivas podem ser localizadas na literatura indicada no edital:

CAMPOS, G. W. S. Fenômenos Intervenientes no Futuro do Sistema Único de Saúde (SUS). In: CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE. CONASS Debate: O futuro dos Sistemas Universais de Saúde. Brasília: CONASS, 2018

ASSERTIVA FALSA: pode ser verificada na página 63 do documento supramencionado, onde o autor propõe a aprovação de legislação para reduzir e não estimular os cargos de livre provimento ou de confiança no SUS.

ASSERTIVA VERDADEIRA: pode ser verificada na página 62 do documento supramencionado

ASSERTIVA VERDADEIRA: pode ser verificada na página 62 do documento supramencionado.

ASSERTIVA VERDADEIRA: pode ser verificada na página 63 do documento supramencionado.

Dessa forma, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 09 - MANTIDA alternativa 'D'. A fim de elucidar os questionamentos e as dúvidas relacionadas à questão nº 9, esclarece-se que as assertivas podem ser localizadas na literatura indicada no edital:

FLEMMING, C. C.; PEREIRA, K. G. Territorialização como instrumento do planejamento local na Atenção Básica. Florianópolis: UFSC, 2016.

Alternativa A: ESTÁ CORRETA, uma vez que afirma que o processo de territorialização requer um planejamento prévio para estabelecer o que se deseja, sem essa prerrogativa o planejamento perde a sua função. Quando não sabemos o que desejamos não há como pensar nas maneiras de obtenção das informações. A alternativa reconhece essa necessidade, o que pode ser verificado na página 31 do documento supramencionado.

ALTERNATIVA D: ESTÁ INCORRETA. Considerando a página 33 da literatura supramencionada, as entrevistas com informantes-chaves são consideradas dados primários e não secundários como descrito na alternativa.

Dessa forma, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 10 - MANTIDA alternativa 'B'. A fim de elucidar os questionamentos e as dúvidas relacionadas à questão nº 10, esclareço que as assertivas podem ser localizadas na literatura indicada no edital:

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, 22 set. 2017, p. 68. Disponível em: http://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html.

ASSERTIVA INCORRETA, as ações e procedimentos considerados estratégicos para o avanço e alcance de condições ELEVADAS DE ACESSO e qualidade na Atenção Básica apresentam-se como padrões ampliados e não essenciais como o descrito na assertiva, o que pode ser verificado no item 3.3 do documento supramencionado.

ASSERTIVA CORRETA: pode ser verificada no documento supramencionado em atribuições dos ACS, item VI.

ASSERTIVA INCORRETA: O teto máximo de equipes de Equipes de Atenção Básica e de Saúde da família para o recebimento de recursos financeiros é calculado a partir da razão população/2000 e não população/3500 como descrito na alternativa, o que pode ser verificado no Item 3.3, subitem iii. do documento supramencionado.

ASSERTIVA CORRETA: pode ser verificada no item 3.6 do documento supramencionado, quando se descreve os itens necessários para o funcionamento das equipes de Consultório na Rua (eCR).

Dessa forma, mantém-se o gabarito.

QUESTÃO: 12 - MANTIDA alternativa 'B'. Segundo a bibliografia utilizada e publicada no edital, Albuquerque (2012) refere que vale destacar alguns marcos pós-ditadura militar. O primeiro deles, considerado um dos resultados mais expressivos do Movimento Sanitário, foi a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, que reuniu milhares de participantes que representavam parte das forças políticas e sociais que lutavam por uma reforma efetiva na política de saúde do país. A referência ainda traz que “Uma das recomendações importantes da VIII CNS foi a criação de uma Comissão Nacional de Reforma Sanitária (CNRS), pelo Ministério da Saúde, que atuaria com legitimidade nas discussões para a elaboração da ‘Nova’ Constituição Federal, de forma a subsidiar os aspectos relacionados à saúde”. Após um ano de discussões, foi promulgada a Constituição e os artigos 196 a 200, especificamente sobre a saúde (BRASIL, 1988). As NOBS vieram após todo este movimento iniciado na década de 70, como uma consequência. Assim, a Conferência destaca-se por ser este marco. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 13 - MANTIDA alternativa 'B'. Bibliografia utilizada e publicada no edital:

ALBUQUERQUE, M. I. N. Uma revisão sobre as Políticas Públicas de Saúde no Brasil. Recife: UNA-SUS UFPE, 2015, pag. 12.

O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Relatório de Gestão são elaborados anualmente. Assim, a segunda assertiva é falsa. As demais são verdadeiras, de acordo com a bibliografia e orientações sobre os instrumentos. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 15 - MANTIDA alternativa 'A'. Bibliografia utilizada e publicada no edital:

BRASIL. Ministério da Saúde. Para entender o controle social na saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

A primeira assertiva é falsa, porque o Conselho não é um órgão consultivo, mas sim deliberativo. A segunda assertiva é falsa, porque o Conselho de Saúde não é subordinado ao poder executivo.

Em relação à paridade, a terceira assertiva é verdadeira, de acordo com a Resolução nº 453 de 2012. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 17 - MANTIDA alternativa 'C'. Bibliografia utilizada e publicada:

Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Anexo I da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

A intersetorialidade se refere ao processo de articulação de saberes, potencialidades e experiências de sujeitos, grupos e setores na construção de intervenções compartilhadas, estabelecendo vínculos, corresponsabilidade e cogestão para objetivos comuns, enquanto a intrasetorialidade diz respeito ao exercício permanente da desfragmentação das ações e serviços ofertados por um setor, visando à construção e articulação de redes cooperativas e resolutivas. A assertiva III traz a intersetorialidade, mas o conceito é de intrasetorialidade, por isso ela está incorreta. Portanto, gabarito mantido.

QUESTÃO: 18 - MANTIDA alternativa 'C'. Bibliografia utilizada e publicada no edital:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: o que se tem produzido para o seu fortalecimento?

O conceito descrito na prova corresponde ao de Educação Permanente em Saúde. O PET-Saúde é um programa voltado para a integração ensino-serviço através de projetos articulados entre as IES e o Serviço, com ênfase na graduação, no intuito de trazer o aluno para vivências próximas ao serviço. A EPS é mais ampla, vai além da graduação. Situa-se especialmente no desenvolvimento do trabalhador do SUS, mas, como estratégia político-pedagógica, abrange toda a formação para o SUS. Esta além de um programa. Portanto, gabarito mantido.

MATÉRIA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CARGO(S): VIGILÂNCIA EM SAÚDE

QUESTÃO: 46 - MANTIDA alternativa 'A'. Na bibliografia de referência, consta:

Página 1: O texto descreve que a febre do Oropouche (FO) é caracterizada por febre de início súbito, com duração de 2 a 7 dias, e geralmente apresenta evolução benigna. Isso pode ser confirmado no trecho que detalha o diagnóstico virológico: "Durante a fase aguda da doença (entre 2 e 7 dias), é possível detectar o material genético (RNA) do vírus por métodos moleculares [...]".

Página 2: Há uma explicação adicional sobre a evolução clínica da doença e os métodos diagnósticos, reafirmando que a febre é geralmente leve, embora complicações raras possam ocorrer: "[...] embora até o momento a apresentação clínica da doença tenha sido relativamente leve, [...]". Com base nesses trechos, a resposta correta para a questão é:

A) súbito – 2 a 7 – benigna.

QUESTÃO: 60 - ANULADA. As alternativas C e D respondem adequadamente à questão, pois a dengue é uma infecção viral amplamente distribuída em diversos territórios. No entanto, há vacinas aprovadas para a dengue, embora sua implementação em larga escala ainda enfrente desafios logísticos e financeiros. Considerando essa perspectiva, a questão pode ser interpretada como ambígua, justificando sua anulação.